



INSTRUCCIÓN DE TRABAJO DE MANEJO Y CUIDADO DEL ACCESO VASCULAR PARA HEMODIÁLISIS – FAVI.

1. ALCANCE.

Inicia aplicando las medidas precautorias y realizando higiene de manos para proceder con el manejo de la fistula arteriovenosa, finaliza con la desinstalación del equipo de la máquina de hemodiálisis.

2. MATERIAL Y EQUIPO

Describe el material y equipo necesarios para la realización de la actividad en mención.

- Material
 - o Mesa de trabajo
 - o Equipo de material para aseo de fistula
 - o material de conexión
 - campo estéril desechable
 - guante estéril desechable (2pzas)
 - gasa estéril 7.5 x 5cm (8pzas)
 - o material de desconexión
 - guante estéril desechable (2pzas)
 - gasa estéril 7.5 x 5cm (6pzas)
 - bandita adhesivo redondo (2pzas)
 - o guante crudo desechable (4pzas)
 - o guante estéril desechable (2pzas)
 - o jeringa de 20ml (1pza)
 - o jeringa 10ml (2pzas)
 - o agujas para canulación de fistula arteriovenosa (2pzas)
 - o cinta adherible hypafix
 - o Soluciones antisépticas en vasos estériles
 - o Alcohol isopropilico 70%
 - o Microdacyn



INSTRUCCIÓN DE TRABAJO DE MANEJO Y CUIDADO DEL ACCESO VASCULAR PARA HEMODIÁLISIS – FAVI.

3. DESARROLLO.

No.	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
5.1	Enfermería	Realizar higiene de manos con agua y jabón “IT-UV-01 Higiene de manos” , y aplica “IT-JE-18 Manejo de las medidas precautorias para el personal de hemodiálisis” .
5.2	Enfermería	Instala al paciente en camilla o reposet asignado y realiza monitoreo de constantes vitales. “IT-JE-39 Admisión, ingreso y egreso del usuario hospitalizado a la unidad de hemodiálisis” “IT-JE-40 Admisión, ingreso y egreso del usuario externo a la unidad de hemodiálisis” Secretaria de salud (2018) Manual para el cuidado estandarizado de enfermería a la persona con acceso vascular para hemodiálisis en el sistema nacional de salud http://www.cpe.salud.gob.mx/site3/programa/docs/manual_terapia_infusion.pdf
5.3	Enfermería	Verificar que el área se encuentre cerrada y evita corrientes de aire.
5.4	Enfermería	Prepara la mesa de trabajo y sanitiza con antiséptico (surfa safe) antes y después de procedimientos, coloca material necesario para realizar procedimiento.
5.5	Enfermería	Realiza lavado de manos.
5.6	Enfermería	Pide al paciente descubrir el área de la fistula (si requiere ayuda al paciente) da posición cómoda y asegura el sitio donde se encuentre el acceso vascular.
5.7	Enfermería	Realiza valoración física de la fistula o injerto, mediante observación, auscultación del soplo y palpación del trill, asegurando la posición del miembro colocándolo sobre superficie firme.
5.8	Enfermería	Abre el equipo de material, set de conexión estéril y agrega las 2 agujas para la punción, dos jeringas de 10 ml, dos guantes estériles, jeringa de 20 ml y prepara las cintas adhesivas hypafix para la fijación.
5.9	Enfermería	Calza un guante en la mano dominante y prepara el material para iniciar asepsia, carga jeringa de 20ml con solución salina y coloca por debajo del área de la fistula el campo estéril desechable.



INSTRUCCIÓN DE TRABAJO DE MANEJO Y CUIDADO DEL ACCESO VASCULAR PARA HEMODIÁLISIS – FAVI.

5.10	Enfermería	Vierte en tres gasas 7.5 x 5cm alcohol isopropílico y en tres gasas más 7.5 x 5cm el antiséptico y se coloca el segundo guante.
5.11	Enfermería	Inicia al aseo de la fistula con las gasas impregnadas con alcohol, realizando movimientos circulares del centro a la periferia, abarcando todo el cuerpo de la fistula, hasta completar tres tiempos y desecha, permitiendo que el alcohol seque solo.
5.12	Enfermería	Realiza la asepsia con las gasas impregnadas con antiséptico, de igual manera en movimientos circulares del centro a la periferia, abarcando todo el cuerpo de la fistula, hasta completar tres tiempos y deja actuar el antiséptico el tiempo que sea especificado por el fabricante, y con gasa seca retira el excedente.
5.13	Enfermería	Se retira y desecha primer par de guantes estériles, y se calza un segundo par, mientras se focaliza el área de anastomosis en caso de fistula autóloga o sitio quirúrgico para injertos protésicos.
5.14	Enfermería	Se inicia con la punción arterial tomando como referencia la anastomosis o sitio quirúrgico, para realizarla a 3cm de distancia y dirigida hacia dichos puntos, a 25 grados de inclinación si es autóloga y 45 grados si es protésica, y observa flujo sanguíneo, conecta jeringa de 10ml y succiona para probar permeabilidad.
5.15	Enfermería	Realiza la punción venosa en la parte superior de la fistula en sentido de la circulación hacia el corazón, observando que exista flujo sanguíneo, conecta la segunda jeringa de 10 ml probando permeabilidad.
5.16	Enfermería	Realiza técnica de fijación de forma inicial por la parte posterior de la aguja y después por las aletillas, evitando girar las agujas antes de la fijación y corrobora la correcta función de las punciones con la jeringa de 20ml pre-llenada antes de conectar a las líneas del circuito extracorpóreo.
5.17	Enfermería	Conecta las extensiones de las agujas al circuito extracorpóreo cubriendo las uniones con gasa estéril 7.5 x 5cm y fija las líneas del circuito para inmovilizarlas.
5.18	Enfermería	Notifica al médico tratante en caso de observar disfunción de flujo, flujo insuficiente, infiltraciones o molestia en sitios.
5.19	Enfermería	Procede al inicio del tratamiento hemodiálisis "IT-JE-26 Intervención de enfermería en el tratamiento de

INSTRUCCIÓN DE TRABAJO DE MANEJO Y CUIDADO DEL ACCESO VASCULAR PARA HEMODIÁLISIS – FAVI.

		hemodiálisis”
5.20	Enfermería	Valora el estado del paciente durante el procedimiento (recomienda precauciones para evitar incidentes), mantiene vigilancia del estado de las punciones, verifica permeabilidad y flujo con la máquina, así como constantes vitales del paciente.
5.21	Enfermería	Finaliza sesión, notifica al usuario que se procederá a la desconexión, verifica el retorno sanguíneo del circuito extracorpóreo con solución salina al 0.9% en circuito cerrado y cierre de clamps, verificando que no existan corrientes de aire antes de la desconexión.
5.22	Enfermería	Realiza higiene de manos “IT-UV-01 Higiene de manos con agua y jabón”, abre el equipo de desconexión estéril y cierra las pinzas de las extensiones de las agujas.
5.23	Enfermería	Calza un par de guantes estériles y desconecta las líneas del circuito de las extensiones de las agujas, toma una gasa estéril seca 7.5 x 5cm retira la aguja proximal y hace hemostasia, procede misma técnica con la aguja distal.
5.24	Enfermería	Realiza hemostasia con el dedo medio e índice de cada mano en cada sitio punción, durante un tiempo de 10 a 15 minutos, o hasta que de confirme la hemostasia; valora que no exista sangrado posterior a ese tiempo y coloca banditas adhesivas.
5.25	Enfermería	Realiza higiene de manos con solución alcoholada, se calza guantes crudos y procede a la desinstalación del equipo de hemodiálisis. “PR-JE-08 Manejo de RPBI”.
5.26	Enfermería	Observaciones: • Puede apoyarse de almohadas para dar una posición cómoda y segura para el usuario sobre la extremidad a usarse, evitando fatiga por posición forzada. • No se recomienda técnica de ojal o punción focalizada en injerto arteriovenoso. • No debe saltarse prueba de permeabilidad y función de punciones, para no exponer la fistula al flujo de la máquina y evitar efectos adversos, como complicaciones estructurales.



INSTRUCCIÓN DE TRABAJO DE MANEJO Y CUIDADO DEL ACCESO VASCULAR PARA HEMODIÁLISIS – FAVI.

	• Si se observa disminución de flujo o infiltraciones, debe valorarse retiro de aguja y nueva punción, notificando siempre al médico tratante • Durante el retorno sanguíneo, se realizan tomas de presión arterial para confirmar la estabilidad hemodinámica del paciente • La presión ejercida en la hemostasia debe ser suave para evitar pérdidas hemáticas y oclusión de vasos.
--	---

4. GESTIÓN DE RIESGOS.

Riesgo	Barrera de Seguridad
a. Fístula arteriovenosa infiltrada por punción incorrecta.	a. Valoración eficiente de la anatomía de la fístula arteriovenosa. b. Aplicar técnica de punción adecuada. c. Verificar flujo sanguíneo.
b. Acceso vascular con datos de infección.	d. Mantener técnica de barrera máxima al manipular la fístula y las líneas. e. Uso de antisépticos adecuados y limpieza eficiente de piel y conectores.
c. Desconexión accidental de las líneas hemáticas.	f. Fijación correcta de las líneas durante la sesión de hemodiálisis.



INSTRUCCIÓN DE TRABAJO DE MANEJO Y CUIDADO DEL ACCESO VASCULAR PARA HEMODIÁLISIS – FAVI.

5. ANEXOS.

5.1 Documentos de referencia.

Nombre del documento	Código
Secretaría de salud (2018) Manual para el cuidado estandarizado de enfermería a la persona con acceso vascular para hemodiálisis en el sistema nacional de salud http://www.cpe.salud.gob.mx/site3/programa/docs/manual_terapia_infusion.pdf	No aplica
Higiene de manos con agua y jabón	IT-UV-01
Manejo de medidas precautorias	IT-JE-18
Intervención de enfermería en el tratamiento de hemodiálisis	IT-JE-26
Admisión, ingreso y egreso del usuario hospitalizado a la unidad de hemodiálisis	IT-JE-39
Admisión, ingreso y egreso del usuario externo a la unidad de hemodiálisis	IT-JE-40
Manejo de residuos peligrosos biológicos infecciosos	PR-JE-08



INSTRUCCIÓN DE TRABAJO DE MANEJO Y CUIDADO DEL ACCESO VASCULAR PARA HEMODIÁLISIS – FAVI.

6. CONTROL DE CAMBIOS.

Versión	Fecha	Descripción del cambio	Realizado	Aprobado
01	Julio 2021	Alta de documento	Toledo Casas Gerardo	Ana Cecilia Zarate Bautista
02	Agosto 2024	Actualización de documento	Mendoza Garcia Mayda Guadalupe	Ana Cecilia Zarate Bautista
03	Septiembre 2025	Actualización de documento	Mendoza Garcia Mayda Guadalupe	Juan Carlos Vanegas Reyes

7. AUTORIZACIÓN.

Elaboró	Revisó	Autorizó
 Lic. Juan Carlos Vanegas Reyes	 Dra. Giselle Ivette De la Torre García	 Hna. María de Jesús García Castro
Jefatura de enfermería	Jefatura de Calidad	Dirección General

